EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90703
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-16 08:56:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: IRIS DE LOS SANTOS VELIZ .			RUN	: 4.818.208-9
F.Nac	: 06-05-1939	Edad	: 85 AÑOS, 3 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-01	Fecha Egreso	: 2024-08-16 08:56:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. S52.0-FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL CUBITO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) SDRA 2°
a) EPOC sobreinfectado 2° a E Faecium tratada
2) IC en vias de compensacion
a) HTP
3) Osteoporosis
4) Hiperkalemia resuelta
5) Hiponatremia leve
6) Fx de codo derecho en manejo ortopédico

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. S52.0-FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL CUBITO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente cona ntec descritos, consulta en primera instancia el 30/07 en contexto de fractura de olecranon derecho, ademas de sospecha de fractura de columna dorsolumbar posterior a caida. No se deja claro si es un compromiso cronico o agudo sobre cronico. Por contusion en zona occipital se solicita TAC de cerebro que descarta lesiones agudas. Al ingreso ex de orina arroja sospecha de itu por lo que se inicia ceftriaxona.
Durante estacia en TMT paciente con evidencia de desaturacion, se continua manejo por parte por medicina por EPOC sobreinfectado.
SE solicita CSB, con desarrollo de E faecium sensible a linezolid, se realiza viraje ATB, sumado a apoyo con O2 suplemenatiro,
Con mejoria posterior de parametros inflamatorios, pero con persistencia de desaturacion, pese a destete.
Se completan 10 dias de terapia ATB con linezolid, sin inconvenientes.
Evaluada por broncopulmonar, quien autoriza uso de O2 suplementario en domicilio.
Paciente acntualmente cursando su dia N° 16 hospitalizada, en condiciones de HODOM para rehabilitacion kinesica

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Se autoriza uso de O2 suplementario en domicilio por parte de broncopulmonar, se continuara con KNT respiratoria a traves de HODOm

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentado 30°
2. Regimen liviano a tolerancia normosodico

3. O2 suplementario para sat 88-92%
4. Trelegy un puff al dia
5. Clonazepam 0,5 mg al dia VO
6. Mantener inmovilizacion con cabestrillo ESD
7. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO SOS por 5 dias
8. Lactulosa 20 cc c/!2 hrs VO por 5 dias
9. Bromuro de ipatropio 4 puff c/6hrs por AC
10. Salbutamol 2 puff c/6hrs por AC
11. Arono un puff al dia
12. BIsolvon 10 cc c/8hrs VO por 7 dias
13. KNT respiratoria una vez al dia
14. Control poli TMT dentro de 10 dias
15. Control poli broncopulmonar dentro de 21 dias

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO